

川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画

F2 施策実現可能性評価

－ 28 施策×5 軸評価による計画施策の優先度可視化 －

【本Excelの位置づけ】	
本Excelは、川崎町第10期介護保険事業計画策定支援業務における【F2 施策実現可能性評価】の成果物である。 引継メモ第4章に基づき、興部町・浦河町・網走市等の子ども計画フォーマットを介護保険分野に踏襲した。	
【シート構成】	
シート①評価概要	川崎町の地域特性10項目／5評価軸（A～E）の定義／5判定記号（◎○△×▲）の凡例
シート②施策実現可能性評価	28施策×5軸評価。総合判定◎10件／○6件／▲2件／△8件／×2件
シート③地域特性格別優先施策	川崎町固有の10課題×5施策分野マトリクスで重点コメント整理
シート④深掘り分析	総合判定◎○の施策（16施策）について実施方法・メリット・デメリットを整理
【判定サマリー】	
◎ 総合最適合（重点施策）	10件（5軸すべて高評価。計画の重点施策候補）
○ 適合（推進）	6件（3～4軸で高評価。計画期間中に着実実施）
▲ 継続中・要強化	2件（既存施策の強化・高度化）
△ 要件付き適合	8件（条件整備・段階実施が必要）
× 実現困難	2件（計画期間中の実施困難）
【川崎町固有の重点論点】	
論点①	高齢化率41.4%（県内5位）→予防・支え合いの早期着手
論点②	中山間・人口減少地域→移動支援・冬季対応が切実
論点③	ユニバーサルサポーター制度（14種別約400名）の活用
論点④	国保川崎病院（公立）を活用した医療介護連携の優位性
論点⑤	認知症基本法対応→チームオレンジ整備・本人意見反映が必須
論点⑥	外出タクシー助成（R7.3終了）の代替施策検討
【F3への接続】	
◎○判定の16施策については、F3アンケート追加設問でニーズ把握項目を設計する。 特に、認知症本人・家族調査（新規調査(1)）は施策18・21・23の前提となる。	
【作成情報】	
作成	（受託予定者）
初版作成日	令和8年4月（入札段階・暫定版）
参考	引継メモ・テンプレート集（計画策定支援業務全体／Version 1.0）
関連ファイル	川崎町_作業チェックリスト_介護保険事業計画.xlsx（F1前提条件整理済）

川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート①：評価概要

1-1 川崎町の地域特性10項目（評価の前提）			
#	特性項目	現状値	施策評価への含意
1	①人口規模	約8,000人台（小規模団体）	サービス資源の限定性が中心論点。広域連携・共生型サービスが鍵
2	②高齢化率	41.4%（令和7年3月31日・宮城県内5位）	第2期計画策定時37.8%から3.6pt上昇。高齢化進行ペースが速い
3	③地理的特性	中山間・人口減少地域（蔵王連峰麓・面積の85%が山岳丘陵）	移動支援・冬季対応・災害時支援が論点
4	④日常生活圏域	1圏域	圏域分割せず、地区別（行政区単位）の取組整理
5	⑤地区区分（参考）	7地区区分（裏丁/前川青根/今宿/川内/本砂金/小野/小沢支倉 基石支倉台）	第2期地福祉計画でアンケート集計に使用
6	⑥独自資源（人材）	ユニバーサルサポーター制度（14種別 約400名）	サロン84/スマイル40/レク29/傾聴24/生活支援コーディネーター25 等
7	⑦認知症資源	サポーター550名・キャラバンメイト73名・支援相談員25名・予防ファシリテーター24名	認知症基本法対応の基盤あり
8	⑧医療資源	国保川崎病院（公立）	保健・医療・福祉連携の核となる存在
9	⑨地域包括支援センター	1か所（社会福祉法人 川崎町社会福祉協議会が運営）	包括的相談支援の唯一の拠点
10	⑩その他独自施策	高齢者紙おむつ等支給／エアコン購入支援（R7.10）／人工透析患者通院交通費助成	外出タクシー助成（R7.3終了）の代替施策検討

1-2 5評価軸の定義（テンプレート集①評価軸定義 準拠）				
軸	評価軸名	定義・着眼点	高評価の条件	低評価の条件
A	法令・制度適合性	介護保険法・老福法・認知症基本法・地域支援事業実施要綱等への適合度	法定事業／基本法対応／国交付金対象	法的根拠弱い／任意事業でも根拠不足
B	実現性	保険料水準・人員体制・委託先確保・準備期間	既存体制で実施可／財源確保済／1年以内開始	新規人員必要／財源未確保／3年以上要
C	地域適合性	川崎町の人口構造・サービス基盤・医療資源・既存取組との整合	地域課題への直接回答／既存資源活用	地域課題と乖離／前提資源なし
D	効果	要介護度改善・健康寿命延伸・介護者負担軽減への貢献度	エビデンスあり／他自治体で実証済	効果測定困難／因果関係不明
E	優先度・緊急性	認知症基本法対応期限・高齢化進行ペース・基盤喪失リスク	計画期間内に実施必須／リスク顕在化	中長期検討事項／他施策で代替可

1-3 5判定記号の凡例		
記号	判定	意味
◎	総合最適合	5軸すべて高評価。重点施策として優先実施
○	適合（推進）	3～4軸で高評価。計画期間中に着実実施

川崎町高齢者保健福祉計画・第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート①：評価概要

1-1 川崎町の地域特性10項目（評価の前提）		
△	要件付き適合	実現性・地域適合性に課題。条件整備や段階実施が必要
×	実現困難	複数軸で低評価。計画期間中の実施困難
▲	継続中・要強化	既存施策の強化。継続実施と高度化が必要

川崎町第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート②：28施策×5軸評価												
■評価軸：A法令制度適合性／B実現性／C地域適合性／D効果／E優先度緊急性　■判定：◎総合最適／○適合／△要件付き／×実現困難／▲継続要強化												
#	分野	施策名	全国代表事例	A法令	B実現	C地域	D効果	E優先	総合判定	判定理由（川崎町固有事情）	備考	
1	①予防	通いの場の拡充・介護予防体操	大東市「大東元気でまっせ体操」（全国モデル）	◎	◎	◎	○	◎	◎	サロンサポーター84名・スマイルサポーター40名等の既存基盤を活用。第2期計画でも重点。継続強化の方向	ユニバーサルサポーター制度の中核	
2	①予防	フレイル予防・健康チェック	東京大学飯島勝矢教授監修「イレブンチェック」／東京都八王子市	◎	○	◎	○	◎	◎	高齢化率41.4%でフレイル対策の重要性高い。健康かわさき21計画との連動でデータ活用可能	国保川崎病院との連携で健診活用	
3	①予防	高齢者の就労・社会参加支援	千葉県柏市「セカンドライフの就労支援」	○	△	△	○	○	△	中山間地域で就労機会が限定的。シルバー人材センターとの連携が前提。地域資源としての就労機会創出が課題	農林業との連携で独自展開可能性	
4	①予防	口腔・栄養・運動の一体的実施	神奈川県大和市「一体的実施」先進市	◎	○	○	◎	◎	◎	後期高齢者保健事業との一体実施が必須化。国保川崎病院・歯科医療機関との連携体制構築が鍵	データヘルス計画と整合	
5	①予防	高齢者の居場所づくり・サロン	秋田県鷹巣町「ケアタウン構想」／兵庫県明石市	○	◎	◎	○	○	▲	サロンサポーター84名の基盤あり。7地区区分での地区別展開が現実的	第2期地福祉計画と連動	
6	①予防	シニアクラブ活動支援	全国老人クラブ連合会「友愛活動」標準モデル	○	○	○	△	△	▲	既存老人クラブの活性化が課題。担い手不足のため再構築型支援が必要	社協との連携必須	
7	②支え合い	生活支援コーディネーター配置・協議体運営	広島県三次市「三次市版協議体」	◎	○	◎	○	◎	◎	生活支援コーディネーター25名の配置済。協議体運営の継続強化が必要	重要な既存資源	
8	②支え合い	住民主体の訪問型・通所型サービス	武蔵野市テンミリオンハウス／埼玉県和光市	○	△	△	○	△	△	総合事業B型の本格展開には担い手・財源・指導者の3要素が必要。段階実施が現実的	ふれあいネットワーク（活動員15・協力員130）活用検討	
9	②支え合い	見守り・安否確認ネットワーク	千葉県柏市「見守りシール」	◎	◎	◎	○	◎	◎	ふれあいネットワーク（協力員130名）の既存基盤あり。独居高齢者増加に対応する重要施策	認知症SOSネットワーク連動可	
10	②支え合い	高齢者の移動支援（送迎・移送）	京都府京丹後市「ささえ合い交通」	△	△	◎	◎	◎	○	中山間地域で最も切実な課題。外出タクシー助成（R7.3終了）の代替策が必須。町民バスとの連動	R7.3で外出タクシー助成終了。代替施策が論点	
11	②支え合い	災害時要援護者支援・個別避難計画	大分県別府市「別府モデル」（全国普及）	◎	○	◎	○	◎	◎	緊急連絡カード（安心カード）・避難行動要支援者管理システム導入済。第2期地福祉計画でも重点	地域防災計画と連携	
12	③サービス	定期巡回・随時対応型訪問介護看護	千葉県柏市「柏プロジェクト」	○	△	△	○	△	×	人口8,000人台では事業所参入の採算が成立しにくい。広域連携または看多機での代替が現実的	近隣市町との広域検討	
13	③サービス	看護小規模多機能型居宅介護（看多機）	長崎県佐世保市普及推進	○	△	△	○	△	△	在宅医療と連動した重要サービスだが、町内事業所の確保が課題。国保川崎病院との連携が鍵	医療介護連携の推進	

川崎町第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート②：28施策×5軸評価												
■評価軸：A法令制度適合性／B実現性／C地域適合性／D効果／E優先度緊急性　■判定：◎総合最適／○適合／△要件付き／×実現困難／▲継続要強化												
#	分野	施策名	全国代表事例	A法令	B実現	C地域	D効果	E優先	総合判定	判定理由（川崎町固有事情）	備考	
14	③サービス	在宅医療・介護連携推進事業	栃木県宇都宮市「医療介護連携センター」	◎	○	◎	◎	◎	◎	国保川崎病院（公立）の存在が大きな強み。地域包括支援センターとの連携体制構築	公立病院の優位性活用	
15	③サービス	在宅看取り・ACP推進	神奈川県横須賀市「エンディングノート」	○	△	○	○	○	○	国保川崎病院・町内医療機関との連携でACP普及が可能。住民への啓発が必要	認知症本人意見反映と連動可	
16	③サービス	地域包括支援センター機能強化	東京都世田谷区分離配置	◎	○	◎	○	◎	◎	社協運営の包括センター（1か所）の機能強化は必須。3職種配置・地域ケア会議運営	社協・町の連携が前提	
17	③サービス	介護給付費適正化事業	愛知県豊田市「ケアプラン点検」	◎	○	○	○	◎	○	保険料抑制の観点で重要。要介護認定の適正化、ケアプラン点検、住宅改修・福祉用具点検	国保連データ活用	
18	④認知症	認知症サポーター養成・チームオレンジ整備	福岡県大牟田市「ほっとあんしんネットワーク」	◎	○	◎	○	◎	◎	サポーター550名の基盤あり。チームオレンジ整備が認知症基本法対応の中核施策	基本法対応【最優先】	
19	④認知症	認知症カフェ（オレンジカフェ）展開	京都府宇治市「れもんカフェ」	○	○	○	○	○	○	本人・家族の交流の場としてニーズ高い。社協・医療機関主催の検討	本人参加型重視	
20	④認知症	認知症初期集中支援チーム強化	愛知県豊田市初期集中モデル	◎	△	○	○	◎	△	国保川崎病院の認知症専門医配置が前提。委託・連携体制の構築が課題	人材確保が論点	
21	④認知症	認知症地域支援推進員配置	神戸市「認知症神戸モデル」	◎	○	◎	○	◎	◎	認知症支援相談員25名の基盤あり。包括支援センター内配置で機能強化	既存資源の発展	
22	④認知症	若年性認知症支援	兵庫県若年性認知症コールセンター	○	△	△	○	○	△	町単独での専門相談体制構築は困難。県の若年性認知症支援センターとの連携が現実的	県事業との連動	
23	④認知症	認知症本人ミーティング・当事者発信	京都府「おれんじドア」	◎	△	○	○	◎	○	認知症基本法 本人意見反映義務への対応。本人・家族アンケート（F3新規調査）が出発点	F3新規調査(1)と連動	
24	⑤人材	介護福祉士修学資金貸付	千葉県・広島県月額5万円＋準備金20万円	○	△	△	○	○	△	町単独事業は財源負担大。県事業との連動・町内事業所への定着支援に絞り込み	県事業活用	
25	⑤人材	潜在介護人材の復職支援金	埼玉県・青森県「再就職準備金」	○	△	○	○	○	△	中山間地域では潜在介護人材自体が少ない。広域連携での実施が現実的	広域連携検討	
26	⑤人材	介護職イメージアップ・体験事業	山形県「介護のお仕事プロモーション事業」	○	○	○	△	△	△	町内中学高校との連携で職場体験事業が可能。即効性は低いが将来基盤として重要	教育委員会連携	

川崎町第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート②：28施策×5軸評価												
■評価軸：A法令制度適合性／B実現性／C地域適合性／D効果／E優先度緊急性 ■判定：◎総合最適合／○適合／△要件付き／×実現困難／▲継続要強化												
#	分野	施策名	全国代表事例	A法令	B実現	C地域	D効果	E優先	総合判定	判定理由（川崎町固有事情）	備考	
27	⑤人材	外国人介護人材の受入支援	愛知県・兵庫県EPA・技能実習受入支援	○	△	△	△	△	×	小規模団体での受入は事業所側のリソース不足で限定的。広域・県事業との連動が前提	現実性低い	
28	⑤人材	介護ロボット・ICT導入支援	厚労省ICT導入支援事業／神奈川県	◎	○	○	○	◎	○	国補助事業活用で町内事業所の負担軽減。LIFE導入と連動した質向上	国事業活用	

■総合判定の集計（28施策中）		
◎	総合最適合（重点施策）	10件 5軸すべて高評価。計画の重点施策
○	適合（推進）	6件 3～4軸で高評価。計画期間中に着実実施
▲	継続中・要強化	2件 既存施策の強化。継続と高度化
△	要件付き適合	8件 条件整備・段階実施が必要
×	実現困難	2件 計画期間中の実施困難

川崎町第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート③：地域特性別優先施策マトリクス

■川崎町の10課題に対し、5施策分野（①予防／②支え合い／③サービス／④認知症／⑤人材）の重要度を整理

地域課題	①予防	②支え合い	③サービス	④認知症	⑤人材	重点コメント（川崎町固有事情）
高齢化率41.4%（県内5位）	◎	◎	○	○	○	5年で3.6pt上昇。予防・支え合いの早期着手が必須。健康寿命延伸と支え手確保を同時に
独居高齢者の増加	○	◎	○	◎	△	ふれあいネットワーク（活動員15・協力員130）の活用。認知症SOS・社会参加促進
介護者の高齢化・介護離職	△	○	◎	◎	○	在宅支援充実・認知症介護者支援・サービス利用促進。本人家族アンケートで実態把握
サービス基盤の不足（人口8,000人台）	△	○	◎	△	◎	事業所誘致は困難。広域連携・既存基盤強化・ICT活用・町内人材確保の3段階戦略
医療介護連携の希薄	○	△	◎	○	△	国保川崎病院（公立）の優位性を活用した医療介護連携センター機能整備が鍵
介護人材不足（県南西部の中山間地）	△	○	○	○	◎	養成・定着・処遇の3段階戦略。広域連携・県事業活用が現実的
認知症基本法対応	○	○	○	◎	○	サポーター550名の基盤あり。チームオレンジ整備・本人意見反映が新規対応
介護費用・保険料上昇	◎	○	△	△	◎	予防重点化と給付適正化で抑制。保険料水準の住民理解促進が必要
地区間格差（7地区）	○	◎	○	○	△	町中心部（裏丁等）と周辺地区（本砂金等）の格差縮小。地区別アプローチ
災害・有事への対応（中山間地）	△	◎	○	○	△	個別避難計画と地域支え合いの連動。冬季対応・移動支援との統合

■マトリクスの読み方: ◎最重点 (5軸高評価) / ○重点 (3~4軸高評価) / △補完 (条件整備で実施)

川崎町第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート④：◎○判定施策の深掘り分析					
■シート②の総合判定で◎○判定となった16施策について、実施方法・メリット・デメリット・川崎町での留意点を整理					
#	分野	施策名	実施方法（具体的事項）	メリット	デメリット・留意点（川崎町固有）
1	①予防	通いの場の拡充・介護予防体操	・既存サロン（サロンサポーター84名）の活動継続支援／・大東市「大東元気でまっせ体操」モデル導入検討／・地区別（7地区）の通いの場展開	①既存基盤強（サポーター84名）／②低コスト／③エビデンスあり（大東市実証）／④第10期重点施策	①サポーターの高齢化・後継者確保／②運営場所の確保（地区集会所活用）／③参加者の定着
2	①予防	フレイル予防・健康チェック	・後期高齢者健康診査と連動した質問票実施（飯島勝矢「イレブンチェック」）／・国保川崎病院での健診活用／・通いの場での個別アプローチ	①国保川崎病院との連携で健診データ活用可／②データヘルス計画と整合／③個別アプローチ可能	①国保川崎病院の協力体制構築／②データ活用ルール（個人情報保護）／③ハイリスク者へのフォロー体制
4	①予防	口腔・栄養・運動の一体的実施	・後期高齢者保健事業との一体実施／・歯科医師会・栄養士会・健康運動指導士との連携／・通いの場での実施	①国の方針で必須化／②既存サロンサポーター活用／③多職種連携で質向上／④国保川崎病院・歯科連携	①歯科衛生士等の人材確保／②町内歯科医療機関の協力体制／③一体実施の運営費財源確保
7	②支え合い	生活支援コーディネーター配置・協議体運営	・既存のSC25名の役割明確化／・第1層協議体の継続運営／・第2層は地区別（7地区）展開を検討／・社協との一体運用	①既存基盤（SC25名）／②社協との連携体制／③ふれあいネットワークと連動可能／④総合事業の中核	①コーディネーター負担の管理／②協議体メンバーの担い手確保／③地区別展開時の効率性確保
9	②支え合い	見守り・安否確認ネットワーク	・ふれあいネットワーク（活動員15・協力員130）の維持強化／・民生委員連動／・配食・新聞販売店等の連携協定／・認知症SOSネットワーク統合	①既存基盤（協力員130名）強／②独居高齢者増加に対応／③低コスト／④認知症対応にも活用	①協力員の高齢化・後継者確保／②個人情報保護ルール／③緊急対応のエスカレーション体制
10	②支え合い	高齢者の移動支援（送迎・移送）	・町民バスの便数・ルート見直し／・京丹後市「ささえ合い交通」モデル検討／・社協の福祉有償運送／・終了したタクシー助成（R7.3終了）の代替検討	①中山間地域で最も切実なニーズ／②外出頻度向上で介護予防効果／③地域参加の前提	①道路運送法上の制約／②運転ボランティアの確保（高齢化）／③財源確保（タクシー助成終了の課題）／④事故リスク・保険
11	②支え合い	災害時要援護者支援・個別避難計画	・避難行動要支援者管理システム継続／・緊急連絡カード（安心カード）配布／・地区別の個別避難計画作成（民生委員・社協連動）／・別府モデル参考	①既存システムあり／②第2期地福祉計画と連動／③国の方針で必須／④災害時の生命保護	①個別計画作成の負担（特に支援者確保）／②要援護者の同意取得／③冬季積雪・道路寸断対応
14	③サービス	在宅医療・介護連携推進事業	・国保川崎病院・町内医療機関・包括支援センターによる協議会運営／・退院支援ルール整備／・ICTでの情報共有／・宇都宮市モデル参考	①公立病院（国保川崎病院）の優位性大／②小規模団体で関係構築しやすい／③医療介護連携の核／④在宅看取りに発展可能	①病院側の協力体制／②情報共有ルール（個人情報保護）／③ICT導入コスト／④医師会との連携

川崎町第10期介護保険事業計画 F2 施策実現可能性評価 ― シート④：◎○判定施策の深掘り分析					
■シート②の総合判定で◎○判定となった16施策について、実施方法・メリット・デメリット・川崎町での留意点を整理					
#	分野	施策名	実施方法（具体的事項）	メリット	デメリット・留意点（川崎町固有）
15	③サービス	在宅看取り・ACP推進	・国保川崎病院・町内医療機関での研修／ ・住民向けACP啓発（出前講座）／・エンディングノート配布（横須賀市モデル）／ ・ケアマネ研修	①国保川崎病院の優位性／②本人意思尊重／③在宅医療連携と整合／④認知症本人意見と連動	①住民の心理的抵抗（死の話題）／②医療従事者研修の機会確保／③意思の文書化と更新の運用
16	③サービス	地域包括支援センター機能強化	・社協運営包括の3職種配置維持／・地域ケア会議の機能強化／・基幹型機能の検討／・職員研修・人材育成	①包括的相談支援の唯一の拠点／②社協連携で地域資源活用可／③既存基盤あり／④重層支援との関係性	①職員確保（特に主任ケアマネ）／②町と社協の役割分担明確化／③地域福祉計画との連動／④基幹型機能の必要性
17	③サービス	介護給付費適正化事業	・要介護認定の適正化／・ケアプラン点検／・住宅改修・福祉用具点検／・縦覧点検／・国保連データ活用（豊田市モデル）	①保険料抑制／②国費補助あり／③国保連委託で実施可能／④5項目の標準事業	①点検実施体制（人員）／②ケアマネとの関係性配慮／③町単独実施の限界（広域連携検討）
18	④認知症	認知症サポーター養成・チームオレンジ整備	・サポーター550名の活動先整理／・チームオレンジ立ち上げ（大牟田市モデル）／ ・本人参加型運営／・小学校・中学校での養成継続	①既存基盤（550名）強／②認知症基本法対応の中核／③国の重点施策／④基本法対応【最優先】	①チームオレンジの実働化（活動内容設計）／②本人参加の方法論／③活動財源・拠点確保／④キャラバンメイト（73名）の活動継続
19	④認知症	認知症カフェ（オレンジカフェ）展開	・社協・医療機関主催のカフェ立ち上げ／ ・既存サロン機能拡充型／・本人家族・専門職の交流／・宇治市「れもんカフェ」参考	①低コストで実施可／②認知症本人・家族の交流／③相談機能／④地域住民の理解促進	①継続運営の担い手／②本人参加の促進方法／③医療機関主催型は専門職負担／④参加者確保（プライバシー配慮）
21	④認知症	認知症地域支援推進員配置	・地域包括支援センター内配置／・認知症支援相談員25名との連携／・初期集中支援チームとの連動／・神戸モデル参考	①既存資源（相談員25名）／②地域包括支援センターとの一体運用／③国補助あり／④基本法対応の中核施策	①推進員専従配置の財源／②社協包括との役割分担／③専門研修受講／④認知症初期集中支援チームとの連動体制
23	④認知症	認知症本人ミーティング・当事者発信	・認知症本人・家族アンケート（F3新規調査(1)）が出发点／・京都府「おれんじドア」モデル／・本人ミーティング定期開催／ ・当事者発信の場づくり	①認知症基本法 本人意見反映義務への対応／②計画策定の根拠資料／③当事者目線の施策評価／④F3新規調査と連動	①参加者確保（プライバシー配慮）／②本人発信の支援体制／③ファシリテーター養成／④継続性確保
28	⑤人材	介護ロボット・ICT導入支援	・町内事業所への国補助事業情報提供／・LIFE（科学的介護情報システム）導入支援／ ・介護ロボット導入の伴走支援／・厚労省ICT導入支援事業活用	①国補助活用で町負担小／②事業所の業務効率化／③ケアの質向上（LIFE）／④第10期重点施策	①事業所側のITリテラシー差／②導入後の活用支援／③町の支援体制（情報提供窓口）／④小規模事業所の対応

■本シートのねらい： ◎○判定16施策の実施可否判断のため、実施方法・メリット・デメリットを具体化。F3アンケート設計時のニーズ把握項目選定の根拠となる